

Clases I a V de relaciones patológicas

Tema 6 · Clasificación de relaciones patológicas

Las cinco clases

Esta clasificación describe **hacia dónde** se desvía la relación mandibular respecto a la posición de referencia:

- **Clase I** · relación protrusiva
- **Clase II** · relación retrusiva
- **Clase III** · relación vertical aumentada
- **Clase IV** · relación latero-protrusiva
- **Clase V** · relación vertical disminuida

No la confundas con la clasificación de Angle, que es otra cosa: Angle describe la relación **molar** anteroposterior.

Clase I · Relación protrusiva

La mandíbula se posiciona **hacia adelante** respecto de donde debería estar.

Suele originarse por interferencias posteriores que obligan a la mandíbula a avanzar para lograr contacto, o por hábitos de postura mandibular adelantada. Los cóndilos quedan desplazados hacia abajo y adelante en la eminencia.

Consecuencias frecuentes: sobrecarga de los anteriores, desgaste incisal marcado y fatiga de los músculos protrusores.

Clase II · Relación retrusiva

La mandíbula queda **hacia atrás**. Es de las más comprometedoras para la articulación, porque el cóndilo se desplaza posteriormente y comprime la zona **retrodiscal**, que está muy vascularizada e inervada.

Por eso este cuadro suele cursar con dolor articular real, no solo muscular. Puede asociarse a pérdida de dientes posteriores, a sobremordida profunda o a restauraciones que no respetaron la posición.

Clase III · Relación vertical aumentada

La dimensión vertical de oclusión está **por encima** de lo que el paciente tolera.

Causa más común: iatrogenia. Restauraciones, prótesis o rehabilitaciones que quedaron altas. También puede darse por erupción pasiva alterada.

Signos: el paciente refiere que no cierra bien o que los dientes le chocan, hay tensión muscular constante, dificultad para juntar los labios y a veces espacio libre interoclusal ausente.

Clase IV · Relación latero-protrusiva

Combina dos desviaciones: la mandíbula se desplaza hacia **adelante y hacia un lado** a la vez.

Es la más compleja de las cinco, porque los dos cóndilos están en posiciones distintas y asimétricas. Suele deberse a interferencias unilaterales que obligan a un desvío en dos planos.

Clínicamente se ve desviación de la línea media en cierre, desgaste asimétrico y sintomatología muscular de un solo lado.

Clase V · Relación vertical disminuida

Pérdida de dimensión vertical. La mandíbula sobrecierra.

Causas: pérdida de dientes posteriores sin rehabilitar, desgaste generalizado severo, o bruxismo de larga evolución.

Signos característicos: tercio inferior de la cara acortado, queilitis angular, labios evertidos, aspecto de mayor edad, y sobrecarga de los dientes anteriores que quedan como único tope. La ATM sufre porque el cóndilo tiende a posicionarse posterosuperior.

Cómo se llega al diagnóstico

No se diagnostican mirando la boca en máxima intercuspidación. Necesitas:

- Modelos **montados en articulador** con arco facial
- Registro en **relación céntrica** y en **posición habitual**
- Comparar ambas posiciones y medir el deslizamiento y su dirección
- Evaluar dimensión vertical y espacio libre interoclusal
- Correlacionar con los signos clínicos y articulares

La dirección del deslizamiento de céntrica a habitual es lo que te dice la clase.

Este material también está disponible en la plataforma, con ejercicios de autoevaluación por niveles y el asistente académico. dentipedia.dentilike.com.mx